



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
MANAJEMEN RESIKO
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN
Panduan Manajemen Risiko RS Prima Husada Sukorejo
Tahun 2025

Panduan Manajemen Risiko RS Prima Husada Sukorejo digunakan sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan program manajemen risiko di unit kerja RS Prima Husada Sukorejo

Disusun oleh:

Komite Mutu



(Lidia Puspita Kencana, S.KM.)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan oleh:

Direktur RS Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panyatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sehingga berhasil menyusun buku Panduan Manajemen Risiko. Buku panduan ini akan digunakan sebagai panduan staff di Rumah Sakit dalam rangka menyusun daftar risiko, dengan elemen elemen alur pelaporan, analisis matrix grading, baik internal maupun eksternal.

Kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna. Untuk itu kami harapkan masukan bagi penyempumaan buku ini dikemudian hari. Panduan ini tersusun atas kerja sama seluruh civitas Rumah sakit Harapan serta dukungan dari berbagai pihak. untuk itu tim penyusun mengucapkan terimakasih dan harapan kami semoga buku ini dapat dipergunakan dengan baik

Pasuruan, 01 November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....4

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA 5

BAB I 7

PENDAHULUAN 7

 1.2 7

 1.3 7

 1.4 7

 1.5 7

 1.5.2 8

 1.5.3 8

BAB II 9

 2.1 9

 2.2 9

BAB III 11

 3.1. 11

 9.1 12

 9.2 13

 9.3 21

BAB IV PENUTUP21

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 935.15/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

TENTANG
PANDUAN MANAJEMEN RISIKO

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang :
- bahwa rumah sakit merupakan tempat yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan kerja baik pasien dan karyawan;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja di rumah sakit perlu diselenggarakan manajemen risiko di rumah sakit agar tercipta kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman;
 - bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107/Menkes/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Resiko
 - Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi RS
 - Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 635.1/DPM/I-KEP/DIR/XII/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada
 - Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PANDUAN MANAJEMEN RISIKO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

- Risiko adalah potensi tindakan (*action*) atau aktivitas (*activity*) yang dipilih (termasuk pilihan tidak bertindak) akan menyebabkan kerugian (*loss*) atau hasil yang tidak diharapkan.



2. Risiko adalah potensial probabilitas proses akan gagal dan menimbulkan error.

Risiko Klinis adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu, aman dan efektif.

3. Risiko Nonklinis / Corporate Risk adalah semua isu yang dapat dapat berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan kewajiban hukum dari RS sebagai korporasi. Medical error, near miss dan adverse event adalah kondisi, event, keadaan yang bisa menimbulkan kegagalan proses.
4. Manajemen risiko rumah sakit / Hospital Risk Management adalah pendekatan proaktif berupa kegiatan untuk mengidentifikasi dan evaluasi untuk mengurangi risiko cedera dan kerugian pada pasien, karyawan rumah sakit, pengunjung dan organisasinya sendiri.
5. Manajemen risiko meminimalkan bahaya terhadap pasien, menciptakan lingkungan yang aman bagi karyawan, pasien dan pengunjung
6. Program Manajemen Risiko adalah identifikasi dan reduksi proaktif *adverse event* yang tidak dapat diantisipasi dan *other safety risks* kepada pasien dan staf.

BAB II

PROGRAM MANAJEMEN RISIKO

Pasal 1

Rumah Sakit mempunyai Program Manajemen risiko rumah sakit yang meliputi identifikasi risiko, prioritas risiko, pelaporan risiko, manajemen risiko, investigasi kejadian yang tidak diharapkan (KTD), manajemen terkait tuntutan (klaim).

BAB III

PENUTUP

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan direktur ini

Pasal 3

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 01 November 2025

Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.

M.Kep.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit berkewajiban untuk mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko strategis dan operasional yang penting. Hal ini mencakup seluruh area baik manajerial maupun fungsional termasuk area pelayanan, tempat pelayanan, area klinis dan area non klinis. Rumah sakit perlu menjamin berjalannya sistem untuk mengendalikan dan mengurangi risiko. Manajemen risiko berhubungan erat dengan pelaksanaan keselamatan pasien dan keselamatan kerja di rumah sakit dan berdampak kepada pencapaian mutu rumah sakit.

RS Prima Husada merupakan rumah sakit kelas C di wilayah Kabupaten Pasuruan dan telah melayani ribuan pasien. RS Prima Husada menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, serta pengabdian kepada masyarakat. Rumah Sakit Prima Husada dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan bermutu dengan aspek pokok kaidah pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan mudah.

RS Prima Husada mempunyai visi menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Visi tersebut di tempuh melalui 3 Misi yaitu memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat. mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien. meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai visi misi tersebut RS Prima Husada akan menghadapi berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat pencapaian visi misi rumah sakit. Ketidakpastian inilah yang disebut dengan risiko. Apabila RS Prima Husada tidak dapat mengelola risiko tersebut, maka dapat dipastikan RS Prima Husada tidak akan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melakukan antisipasi terhadap kondisi ketidakpastian di masa yang akan datang dan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan no 25 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, RS Prima Husada dituntut untuk dapat mengelola risiko yang ada secara terintegrasi. Manajemen risiko merupakan cara pendekatan yang tepat untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran RS Prima Husada. Manajemen risiko dapat diterapkan ke seluruh satuan kerja lingkup RS Prima Husada.

1.2 Maksud tujuan dan manfaat

Maksud Pedoman manajemen risiko terintegrasi dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan dan informasi untuk pengambilan keputusan
- b. Perlindungan terhadap satuan kerja dan pegawai, dan
- c. Mengurangi kejutan atas Risiko yang tidak diinginkan.

1.3 Tujuan

Pedoman manajemen risiko terintegrasi ditujukan untuk:

- a. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien
- b. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi
- c. Memberikan dasar pada setiap pengambilan keputusan dan perencanaan, dan
- d. Meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja

1.4 Manfaat

- a. Meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
- b. Melindungi pasien, staf klinis, tenaga kesehatan dan tenaga lain yang bekerja di rumah sakit, fasilitas dan lingkungan, bisnis rumah sakit
- c. Mengurangi risiko yang tidak diinginkan.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup manajemen risiko rumah sakit meliputi

- a. Pasien dan keluarga
- b. Pengunjung
- c. Staf Medis

- d. Tenaga Kesehatan Lain yang bekerja di rumah sakit
- e. Fasilitas dan lingkungan Rumah Sakit yang terdiri dari:
 - 1) keselamatan dan keamanan :
 - a. Keselamatan: keadaan tertentu karena gedung, lantai, halaman dan peralatan rumah sakit yang menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien, staf dan pengunjung
 - b. Keamanan: risiko terhadap kehilangan, pengrusakan dan kerusakan, atau penggunaan akses oleh mereka yang tidak berwenang
 - c. bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbahnya: riakles penanganan, penyimpanan, dan penggunaan bahan radioaktif serta bahan berbahaya lainnya dan limbah bahan berbahaya
 - d. penanggulangan bencana (emergency): risiko kemungkinan terjadi bencana, respons bila terjadi wabah, bencana dan keadaan emergensi termasuk evaluasi lingkungan pasien secara terintegrasi
 - e. proteksi kebakaran (fire safety): risiko kebakaran dari property/ bangunan dan penghuninya
 - f. peralatan medis risiko pemilihan,eliharaan, dan penggunaan alat medis
 - g. Sistem penunjang (utilitas) risiko kegagalan pengoperasionalan Listrik, air, dan sistem pendukung lainnya

f. Bisnis rumah sakit

1.5.2 Pengelompokan berdasarkan kategori risiko

- a. Strategi (terkait dengan tujuan organisasi): risiko yang mempengaruhi pedoman rencana jangka panjang untuk pencapaian tujuan
- b. Operasional (rencana pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi): proses internal/ eksternal yg mempengaruhi operasional organisasi
- c. Keuangan (menjaga aset): segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap keuangan dan belanja organisasi
- d. Kepatuhan (kepatuhan terhadap hukum dan peraturan): tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan ketentuan yg berlaku kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
- e. Reputasi (image yang dirasakan oleh masyarakat): menurunnya kepercayaan publik masyarakat karena persepsi negative/image yang dirasakan masyarakat
- f. Kebijakan kebijakan organisasi baik internal eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi
- g. Risiko Legal: tuntutan hukum terhadap organisasi
- h. Risiko Fraud kecurangan oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara

1.5.3 Pengelompokan berdasarkan jenis risiko

- a. Risiko klinis antara lain:
 - 1. Risiko terkait dengan sistem manajemen obat
 - 2. Risiko jatuh
 - 3. Pengendalian risiko infeksi
 - 4. Risiko terkait dengan masalah gizi
 - 5. Risiko fasilitas dan peralatan (risiko kebakaran, cedera karena penggunaan laser, risiko-risiko yang diakibatkan dari kondisi jangka panjang)
- b. Risiko Nonklinis
 - 1. Risiko keuangan
 - 2. Risiko hukum
 - 3. Risiko properti
 - 4. Risiko reputasi

BAB II

KEBIJAKAN DAN DASAR HUKUM

2.1 Kebijakan

1. Rumah sakit mempunyai regulasi berupa pedoman manajemen risiko terintegrasi dan program manajemen risiko yang luas tidak terbatas pada pasien, staf medis, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, fasilitas rumah sakit, lingkungan rumah sakit dan bisnis rumah sakit
2. Rumah sakit menyusun program manajemen risiko berkelanjutan digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi risiko
3. Rumah sakit mempunyai daftar risiko di tingkat unit dan tingkat rumah sakit
4. Rumah sakit telah membuat strategi untuk mengurangi risiko yang ada
5. Manajemen risiko harus diterapkan secara terintegrasi seluruh area program dan kegiatan
6. Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan manajemen risiko terintegrasi dibentuk Tim Penyelenggara Manajemen Risiko Terintegrasi yang terdiri atas Bidang/bagian, K3RS, PPI, Ka. Instalasi sebagai penanggung jawab pada unit kerjanya.
7. Setiap satuan kerja harus membuat dan menetapkan daftar risiko dan menyusun rencana perlakuan risiko.
8. Daftar risiko yang telah ditetapkan harus disampaikan kepada Direktur
9. Rumah sakit telah melakukan failure mode effect analysis/ efek modus kegagalan (FMEA/AEMK), Hazard Vulnerability Analysis (HVA), Infection Control risk Assessment (ICRA), Pre Construction risk Assessment (PCRA), Hospital Safety Index (HSI) setahun sekali pada proses berisiko tinggi yang diprioritaskan
10. Rumah sakit telah melakukan tindak lanjut hasil failure mode effect analysis/ efek modus kegagalan (FMEA/AEMK), Hazard Vulnerability Analysis (HVA) Infection Control risk Assessment (ICRA), Pre Construction risk Assessment (PCRA), Hospital Safety Index (HSI)
11. Manajemen risiko harus diterapkan secara terintegrasi seluruh area program dan kegiatan

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja:
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/Menkes/Per/XI/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran,
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/Per/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Struktural Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1787/Menkes/Per/XII/2010

-
- tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/11/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit.
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementrian Kesehatan;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 52 Tahun tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2018
 24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor di 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
 28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit
 29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
 30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit
 31. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik
 32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1354/2024 Tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan
 33. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi RS
 34. Pedoman Tata Laksana Pemulasaraan Jenasah Kemenkes 2024
 35. Rencana strategis RS Prima Husada tahun 2022-2026

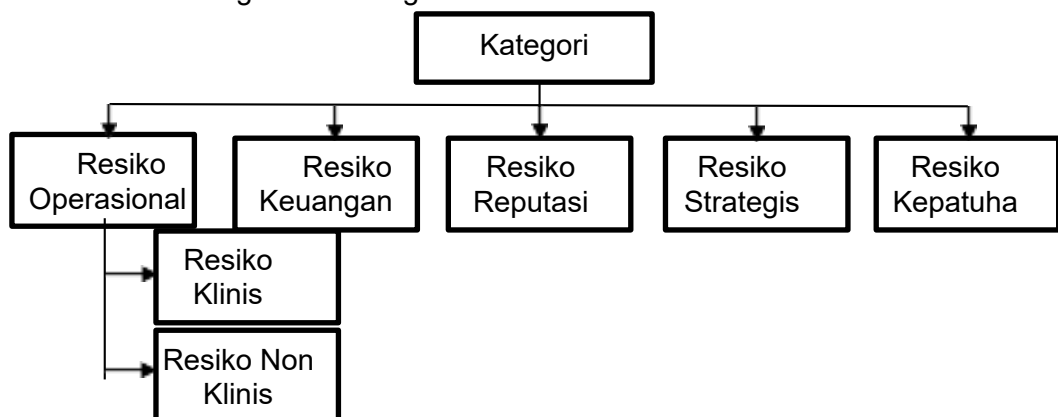
BAB III KEGIATAN MANAJEMEN RESIKO

3.1. Manajemen Resiko

Untuk dapat menanggulangi semua risiko yang mungkin terjadi, diperlukan sebuah proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko. Adapun beberapa definisi manajemen risiko dari berbagai literatur yang didapat, antara lain :

- 1) Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia di rumah sakit.
- 2) Manajemen Risiko adalah suatu kegiatan untuk mengantisipasi, mengurangi, mencegah terulangnya kejadian pada pelanggan internal dan eksternal dengan identifikasi, analisis, evaluasi, pengelolaan dan monitoring risiko.
- 3) Manajemen Risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk mewujudkan peluang peluang sambil mengelola efek yang tidak diharapkan. (AS/NZS 4360:2004)
- 4) Manajemen Risiko merupakan aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko, dengan menekankan pada prinsip integrasi, strukturalisasi, inklusivitas, dinamika dan berbasis informasi terbaik yang tersedia. (ISO 31000:2018)
- 5) Manajemen Risiko merupakan proses formal dimana faktor-faktor risiko secara sistematis diidentifikasi, diukur, dan dicari.

Bagan 9.1 Kategori Risiko di Rumah Sakit



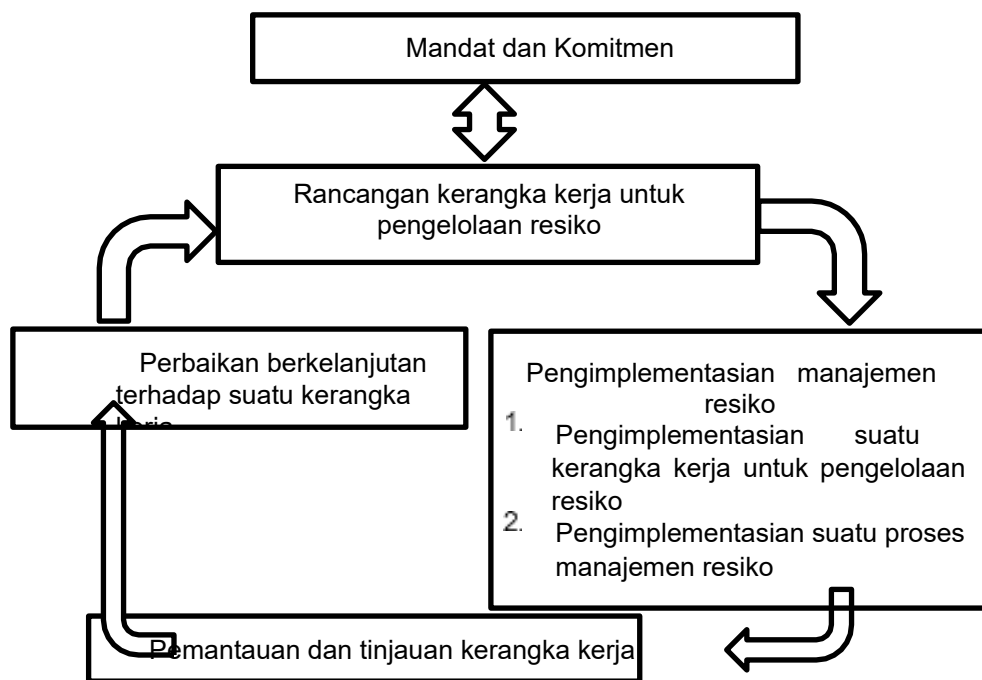
Di rumah sakit risiko dikategorikan menjadi beberapa jenis, berikut merupakan kategori manajemen risiko : Kategori risiko di Rumah sakit dibagi menjadi 5, yaitu :

1. Risiko operasional : risiko yang terjadi saat Rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien baik klinis maupun non klinis.
 - a. Risiko klinis : risiko operasional yang berkaitan dengan pelayanan kepada pasien (*patient safety*) meliputi risiko yang berhubungan dengan perawatan klinis & pelayanan penunjang seperti kesalahan diagnostic, bedah atau pengobatan.
 - b. Risiko non klinis : risiko operasional antara lain risiko PPI (sterilisasi, laundry, gizi, kamar jena-zah dll), risiko MFK (terkait dng fasilitas dan lingkungan, seperti kondisi bangunan yg membahayakan, risiko yg terkait dengan ketersediaan sumber air & listrik, dll. Unit klinis maupun non klinis dapat memiliki risiko yg lain sesuai dengan proses bisnis atau kegiatan yang dilakukan di unitnya. Misalnya unit humas dapat mengidentifikasi risiko reputasi dan risiko keuangan
2. Risiko keuangan : risiko kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Risiko reputasi : citra rumah sakit yang dirasakan oleh masyarakat, Jika reputasi rumah sakit rusak, maka kerugian dalam waktu cepat dapat dirasakan, seperti pasien yang mulai ragu menggunakan jasa pelayanan rumah sakit.
4. Risiko strategis : terkait dengan rencana strategis termasuk tujuan strategis Rumah sakit.
5. Risiko kepatuhan : terhadap hukum dan regulasi Dalam kasus ekstrim, sebuah risiko kepatuhan dapat juga berdampak pada masa depan bisnis rumah sakit, akan menjadi risiko strategis juga

3.2. Kerangka Kerja Manajemen Resiko

Keberhasilan manajemen resiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan di Rumah sakit. Kerangka kerja membantu Rumah sakit mengelola resiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen. Tujuan dari kerangka kerja manajemen resiko adalah untuk memastikan bahwa informasi tentang resiko yang berasal dari proses manajemen resiko dapat dilaporkan dengan baik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemenuhan akuntabilitas yang relevan di semua unit yang ada di Rumah sakit.

Bagan 9.2 Kerangka Kerja Manajemen Resiko



Bagian awal dari manajemen resiko adalah memastikan adanya mandate dan komitmen yang kuat dan berkelanjutan oleh seluruh struktur manajemen resiko dan seluruh pemangku kepentingan turut serta dalam melakukan perencanaan strategis untuk mencapai komitmen di semua tingkatan. Untuk mencapai komitmen di semua tingkatan, seluruh struktur manajemen resiko dan seluruh pemangku kepentingan harus melakukan :

1. Mendefinisikan dan mendukung kebijakan manajemen resiko
2. Memastikan bahwa budaya dan kebijakan manajemen resiko di Rumah sakit berjalan selaras
3. Menentukan indikator kinerja manajemen resiko yang sejalan dengan indikator kinerja di Rumah sakit
4. Menyelaraskan tujuan manajemen resiko dengan tujuan strategi Rumah sakit
5. Memastikan kepatuhan hukum dan peraturan
6. Menetapkan akuntabilitas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi di Rumah sakit
7. Memastikan bahwa sumberdaya yang diperlukan dialokasikan untuk manajemen resiko
8. Menyampaikan manfaat manajemen resiko kepada semua stakeholder
9. Memastikan bahwa kerangka kerja mengelola resiko sesuai

Setelah Rumah sakit menentukan mandat dan memiliki komitmen untuk menjalankan manajemen resiko yang selaras di semua tingkatan dan *stakeholder* . langkah selanjutnya yg dilakukan yakni membuat rancangan kerangka kerja untuk mengelola resiko di Rumah sakit.

1. Pemahaman organisasi dan konteksnya

-
2. Penetapan kebijakan manajemen resiko
 3. Akuntabilitas
 4. Integrasi ke dalam proses organisasi
 5. Sumberdaya
 6. Penetapan mekanisme komunikasi dan pelaporan internal
 7. Penetapan mekanisme komunikasi dan pelaporan eksternal

Setelah terbentuk rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan resiko di rumah sakit, selanjutnya akan dilakukan yakni mengimplementasikan kerangka kerja manajemen resiko untuk mengelola resiko yang ada di setiap unit kerja. Dalam melaksanakan kerangka kerja yang dibuat dapat dilaksanakan dengan :

1. Menerapkan kerangka kerja untuk mengelola resiko
 - a. Menentukan waktu yang tepat dan strategi untuk menetapkan kerangka kerja
 - b. Menetapkan kebijakan dan proses manajemen resiko pada setiap proses pelayanan di Rumah sakit
 - c. Mematuhi persyaratan hukum dan peraturan
 - d. Memastikan bahwa pengambilan keputusan termasuk pengembangan dan penetapan tujuan, sejalan dengan hasil dari proses manajemen resiko
 - e. Berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para pihak terkait untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen resiko tetap sesuai

2. Menerapkan proses manajemen resiko

Manajemen resiko harus dilaksanakan dengan memastikan bahwa proses manajemen resiko diterapkan melalui rencana manajemen resiko di semua tingkat dan fungsi Rumah sakit yang relevan sebagai bagian dari praktis dan proses

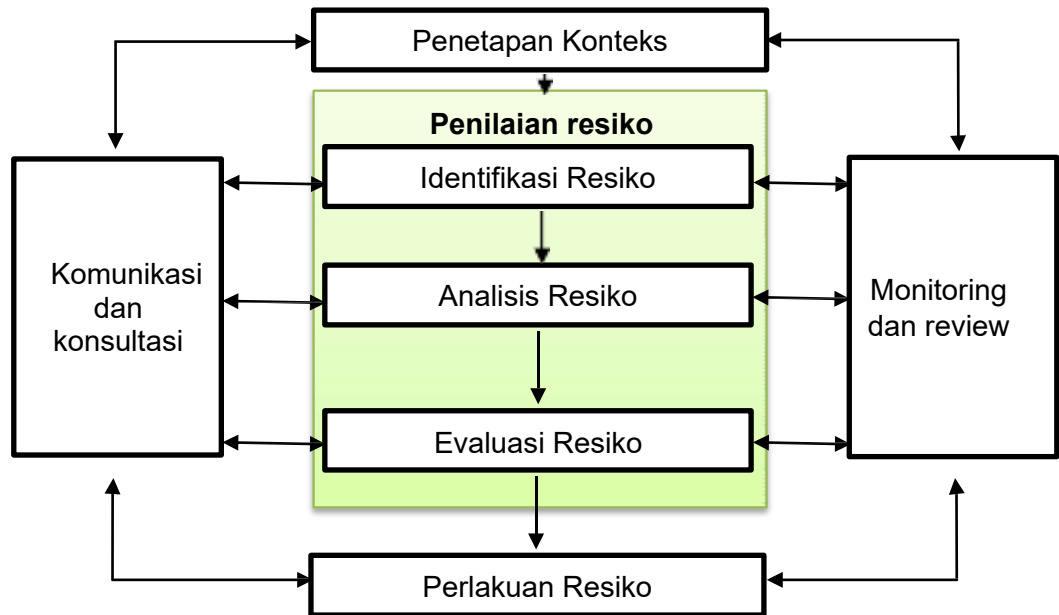
Untuk memastikan pengimplementasian manajemen resiko di Rumah sakit berjalan secara efektif dan berkelanjutan, Rumah sakit harus melakukan kegiatan *monitoring* dan *review* kerangka manajemen resiko yang dapat dilakukan melalui:

1. Mengukur kinerja penerapan manajemen resiko melalui indikator dan dilakukan *review* secara berkala
2. Mengukur secara berkala hasil positif berupa kemajuan maupun hasil negative berupa penyimpangan dari rencana manajemen resiko yang sudah ditentukan
3. Meninjau kesesuaian kerangka kerja manajemen resiko maupun kebijakan tentang manajemen resiko dengan kondisi *eksternal* dan *internal* Rumah sakit
4. *Review* efektivitas kerangka kerja manajemen resiko

3.3. Proses Manajemen Resiko

Proses manajemen resiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen Rumah sakit yang masuk menjadi bagian dari budaya kerja Rumah sakit, praktek terbaik yang dilakukan oleh Rumah sakit dan proses bisnis di Rumah sakit. Berikut merupakan proses manajemen resiko.

Bagan 9.3 Proses manajemen resiko



Proses manajemen resiko terbagi menjadi 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Komunikasi dan konsultasi

Merupakan proses interaktif dalam hal menukar informasi dan pendapat yang mencakup berbagai pesan mengenai resiko dan pengelolaannya. Proses ini berjalan secara internal di Rumah sakit, maupun di setiap unit atau *stakeholder eksternal*.

Konsultasi di artikan sebagai proses komunikasi di Rumah sakit, yang biasanya dilakukan oleh setiap unit dengan pimpinan Rumah sakit mengenai isu tertentu, terkait dengan pengambilan keputusan termasuk penerapan manajemen resiko. Bentuk komunikasi dan konsultasi dapat berupa :

- Rapat berkala
- Rapat insidental
- Seminar/sosialisasi/*workshop*
- Forum pengelola resiko

Selain bentuk diatas, komunikasi dan konsultasi juga dapat dilakukan melalui media elektronik. Pelaksanaan komunikasi dna konsultasi merupakan tanggung jawab pemilik resiko.

2. Penetapan Konteks

Penerapan konteks merupakan suatu teknik untuk mengartikan tujuan dan mendefinisikan parameter *eksternal* dan *internal* untuk diperhitungkan ketika mengelola resiko, kemudian menetapkan ruang lingkup dan kriteria resiko untuk prosedur selanjutnya. Dalam menentukan konteks perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Konteks *Eksternal*

Merupakan situasi yang berasal dari luar Rumah sakit yang dapat mempengaruhi cara pengelolaan resiko di lingkungan rumah sakit. Konteks *eksternal* dapat meliputi :

- Hukum, social, budaya, politik, regulasi, keuangan, teknologi, lingkungan ekonomi, alam dan persaingan dengan Rumah sakit lain dalam lingkup nasional, regional maupun internasional
- Hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan *eksternal*, dll

b. Konteks *Internal*

Merupakan segala sesuatu dari dalam rumah sakit yang dapat mempengaruhi cara Rumah sakit dalam mengelola resiko yang ada. Kontek *internal* dapat berupa :

- Tata kelola, struktur, peran dan akuntabilitas rumah sakit
- Kebijakan, sasaran dan strategi
- Kemampuan dan pemahaman tentang sumber daya (modal, waktu, staff, peosedur, sistem dan teknologi)

4. Hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan internal dan busya organisai
 5. Sistem informasi, arus informasi dan prosedur pengambilan keputusan
3. Penilaian Resiko

Penilaian resiko terdiri dari 3 (tiga) proses yakni : identifikasi resiko, analisis resiko dan evaluasi resiko.

1) Identifikasi resiko

Setiap unit kerja di Rumah sakit harus melakukan identifikasi sumber resiko, area dampak, peristiwa (termasuk perubahan keadaan), penyebabnya dan konsekuensi potensi resiko. Tujuan dilakukan identifikasi resiko yakni untuk menghasilkan daftar lengkap resiko berdasarkan peristiwa yang mungkin terjadi di unit, sehingga Rumah sakit dapat melakukan kegiatan *preventif* untuk menurunkan, mencegah agar resiko yang di identifikasi tidak terjadi. Metode identifikasi resiko dapat dilakukan dengan beberapa metose, Rumah sakit prima husada menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA). Untuk melaksanakan identifikasi resiko di lingkungan unit kerja dapat dilakukan langkah-langkah berikut :

- a. Memahami dan mengidentifikasi kegiatan utama unit kerja
- b. Mengidentifikasi tujuan dari masing-masing kegiatan
- c. Mengumpulkan data dan informasi tentang resiko yang mungkin terjadi di unit kerja, baik resiko yang sudah pernah terjadi maupun yang belum pernah terjadi
- d. Mencari penyebab dari resiko-resiko yang telah teridentifikasi untuk mendapatkan penyebab utamanya
- e. Mengidentifikasi apakah penyebab tersebut sifatnya dapat dikendalikan (*controllable*) atau atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) bagi unit kerja.
- f. Mengidentifikasi dampak jika resiko tersebut terjadi
- g. Mengisis hasil butir a-f dalam formulir identifikasi resiko dan memperbaharui setiap saat terjadi pernyataan resiko.

Identifikasi pernyataan resiko dapat dilakukan dengan mendasarkan pada hasil penilaian resiko sebelumnya dengan penyelarasan terhadap perkembangan situasi lingkungan *internal* dan *eksternal* yang terjadi. Untuk menjamin identifikasi resiko yang komprehensif, resiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan di Rumah sakit. Kategori resiko minimal di Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Kategori resiko

Kategori Resiko	Definisi
Resiko keuangan	Resiko disebabkan oleh segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan belanja di Rumah sakit
Resiko Kepatuhan	Resiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi
Resiko Legal	Resiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang –undangan dan ketentuan lain yang berlaku
Resiko Fraud	Resiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada rumah sakit
Resiko Reputasi	Resiko yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan public / masyarakat yang bersumber dari persepsi negatif pelayanan rumah sakit
Resiko Operasional	Resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi

Selain memperhatikan kategori resiko, kategori dampak juga sangat penting dalam

menjami identifikasi resiko yang komprehensif. Kategori dampak disusun sesuai dengan kondisi lingkungan di Rumah sakit. Kategori dampak minimal di Kementerian Kesehatan tertera pada tabel berikut :

Tabel 9.2 Kategori Dampak

Skor	Derajat (Tingkat)	Dampak Keuangan	Tuntutan Ganti Rugi	Penundaan Pelayanan	Dampak pada Kesehatan & Keselamatan	Reputasi	Dampak pada pihak terkait
1	Sangat rendah	≤ 3% Anggaran	≤ Rp 1 juta	≤ 1 hari	Luka kecil pada orang atau beberapa orang	Diketahui oleh sesi kantor	Hanya berdampak pada satu pihak
2	Rendah	> 3 – 5 % Anggaran	> Rp 1 – 5 juta	> 1 – 2 hari	Luka kecil berarti pada orang atau beberapa orang	Dimuat oleh media massa lokal namun cepat dilupakan masyarakat	Berdampak pada 2 - 3 pihak
3	Sedang	> 5 – 8 % Anggaran	> Rp 5 – 25 juta	> 2 – 3 hari	Luka berarti pada orang atau beberapa orang	Dimuat oleh media massa lokal & media sosial namun cepat dilupakan masyarakat	Berdampak pada 3 - 4 pihak
4	Tinggi	> 8 - 12 % Anggaran	> Rp 25 – 50 juta	> 3 – 5 hari	Luka berat pada orang atau beberapa orang	Dimuat di media nasional dan media online dan sangat sulit untuk dilupakan masyarakat	Berdampak pada 4 - 5 pihak
5	Sangat Tinggi	> 12 % Anggaran	> Rp 50 juta	> 5 hari	Luka berat atau kematian atau cacat permanen	Dimuat oleh media nasional/ internasional dan media sosial/media online diingat lama oleh masyarakat	Berdampak pada lebih 5 pihak

2) Analisis Resiko

Pada proses ini, unit menganalisis resiko mana yang akan dilakukan evaluasi, perlu ditangani. Selain itu, unit juga harus menentukan strategi dan metode yang akan digunakan untuk penanganan yang paling tepat. Kegiatan analisis resiko yang dilakukan oleh Rumah sakit adalah mengkaji penyebab dan sumber resiko , akibat yang akan ditimbulkan jika kemungkinan resiko yang diidentifikasi terjadi.

Suatu insiden dapat menimbulkan permasalahan yang bermacam-macam sehingga dapat mempengaruhi berbagai tujuan yang ditentukan oleh Rumah sakit. Untuk melaksanakan analisis resiko di Rumah sakit, langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :

- a. Rumah sakit harus memiliki hasil identifikasi resiko setiap unit kerja
- b. Hasil identifikasi di evaluasi atas kecukupan disain dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang sudah ada
- c. Ukur tingkat probabilitas terjadinya resiko

Tabel 9.3 Probabilitas resiko Non Klinis

Level kemungkinan (probabilitas)	Kriteria Kemungkinan (Probabilitas)
Hampir tidak terjadi 1	Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa Persentase 0-10%
Jarang Terjadi 2	Peristiwa diharapkan tidak terjadi Persentase > 10-30%
Kadang Terjadi 3	Peristiwa kadang-kadang terjadi Persentase > 30-50%
Sering Terjadi 4	Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi Persentase >50-90% dalam 1 periode
Hampir Pasti Terjadi 5	Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi Persentase >90% dalam 1 periode

Tabel 9.3 Probabilitas resiko Klinis

Level kemungkinan (probabilitas)	Kriteria Kemungkinan (Probabilitas)
Hampir tidak terjadi 1	Sangat Jarang / Rare >5 tahun / kali
Jarang Terjadi 2	Jarang / Unlikely >2-5 tahun / kali

Kadang Terjadi 3	Mungkin / Possible 1-2 tahun / kali
Sering Terjadi 4	Sering / Likely Beberapa kali / tahun
Hampir Pasti Terjadi 5	Sangat sering / almost certain Tiap minggu / bulan

d. Ukur tingkat besaran dampak resiko yang terjadi

Tabel 9.4 Dampak (Konsekuensi) Non Klinis

Level Dampak	Area Dampak
Sangat Rendah 1	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi / kegiatan secara umum
	Agak mengganggu pelayanan
	Dampak dapat ditangani pada tahap rutin
	Kerugian kurang material dan tidak dipengaruhi <i>stakeholder</i>
Rendah 2	Mengganggu pencapaian tujuan instansi / kegiatan meskipun tidak signifikan
	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program
	Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi <i>stakeholder</i>
Sedang 3	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan
	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
	Mengganggu administrasi program
	Kerugian keuangan cukup besar
Tinggi 4	Sebagian tujuan instansi / kegiatan gagal dilaksanakan
	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi
	Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan
Sangat Tinggi 5	Sebagian besar tujuan instansi / kegiatan gagal dilaksanakan
	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholder</i>
	Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

Tabel 9.4 Dampak (Konsekuensi) Klinis

Tingkat Resiko	Deskripsi	Dampak
1	Insignificant	Tidak ada cedera
2	Minor	Cedera ringan, misalnya luka lecet Dapat diatasi dengan pertolongan pertama
3	Moderate	Cedera sedang, misalnya luka sobek Berkurangnya fungsi motoric, psikologis atau intelektual Setiap kasus memperpanjang perawatan
4	Mayor	Cedera luas / berat, misalnya lumpuh, cacat Kehilangan fungsi tubuh, sensorik, psikologis, intelektual Tidak berhubungan dengan penyakit
5	Ekstrem	Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

- e. Hitung tingkat / level resiko, yaitu perkalian probabilitas dengan dampak.
- Level resiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu level kemungkinan terjadinya resiko (probabilitas) dan level dampak (konsekuensi) resiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan level resiko. Penentuan level resiko beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan matriks analisis resiko yang kemudian akan dikalikan dengan matriks bobot sebagai berikut :

Tabel 9.5 Matriks Analisis Resiko Non Klinis

Matriks Analisis Resiko			Dampak				
			1	2	3	4	5
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
P R O B A B I L I T A S	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Mungkin terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Tabel 9.5 Matriks Analisis Resiko Klinis

Probabilitas	Dampak				
	1	2	3	4	5
1	Moderate	Moderate	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
2	Moderate	Moderate	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
3	Rendah	Moderate	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
4	Rendah	Rendah	Moderate	Tinggi	Ekstrim
5	Rendah	Rendah	Moderate	Tinggi	Ekstrim

Tabel 9.5 Matriks Analisis Besaran Resiko

Matriks 5 x 5			Bobot Dampak				
			Tdk Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Katastropik
			1	2	3	4	5
Kemungkinan	Hampir Pasti Terjadi	5	1,5	1,4	1,13	1,15	1
	Kemungkinan Besar	4	1,2	1,19	1,3	1,16	1,2
	Kemungkinan Sedang	3	1,17	1,42	1,43	1,46	1,47
	Kemungkinan Kecil	2	1	1,8	1,83	1,9	2,1
	Jarang	1	1	1,5	2	3	4

- f. Buat peringkat resiko untuk menentukan apakah resiko tersebut termasuk resiko sangat rendah, rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi. Berikut merupakan tabel peringkat resiko.

Tabel 9.6 Peringkat Resiko

Warna	Level dimulai dari status resiko	Level	Deskripsi Status Resiko
	>15	5	Sangat tinggi
	10 - 14	4	Tinggi
	5 - 9	3	Sedang
	3 - 4	2	Rendah
	1 - 2	1	Sangat Rendah

- g. Isikan hasil langkah (a) s.d (f) ke dalam formulir analisis resiko

Tabel 9.7

Peringkat Analisis Resiko

No	Ke gia tan	Tuj ua n	K o d e R e s i k o	Pe ry at aa n Re s i k o	Se ba b	C /C	Dam pak	Pengendalian yang ada					P	D	B	TR	PR	Pemili k Re sik o	
								U r a i a n	Desa in		Efektifkita s								
									A	T	TE	E							KE
1																			
2																			

Keterangan :

Keterangan :

- No : di isi dengan nomor urut
- Kegiatan : di isi dengan nama kegiatan
- utama Tujuan Kegiatan : di isi dengan tujuan kegiatan
- Kode resiko : di isi dengan kode / nomor resiko
- Pernyataan resiko : di isi dengan pernyataan resiko, potensi, yang di
- Identifikasi Sebab : berdampak terhadap pencapaian tujuan
- UC / C : di isi dengan kategori penyebab, apakah *uncontrollable* (UC) *controllable* (UC)

Dampak	: di isi dengan uraian dampak, jika kolom (pernyataan resiko) terjadi
A	: di isi tanda centang (√), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (uraian)
T	: di isi tanda centang (√), jika tidak ada kegiatan Pengendalian
TE	: di isi tanda centang (√), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi resiko
KE	: di isi tanda centang (√), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
E	: di isi tanda centang (√), jika kegiatan pengendalian yang ada efektif mengurangi resiko
P	: di isi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya resiko. Tingkat kemungkinan terjadinya resiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
D	: di isi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat dampak resiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
B	: diisi dengan bobot (B) yang merupakan matriks hasil perkalian dampak dan probabilitas
TR	: di isi dengan tingkat resiko yaitu perkalian antara probabilitas, dampak dan bobot
PR	: di isi dengan peringkat resiko, apakah “sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi
Pemilik Resiko	: di isi dengan siapa yang bertanggung jawab atas resiko (pemilik resiko)

- h. Dari resiko-resiko tersebut di atas, selanjutnya dibuat peta resiko (gambaran total resiko dan distribusi posisinya dalam grafik dengan frekuensi pada sumbu horizontal (x) dan konsekuensi pada sumbu vertikal (y))

3) Evaluasi resiko

Evaluasi resiko adalah proses membandingkan antara hasil analisa resiko dengan kriteria resiko untuk menentukan apakah resiko dapat diterima atau ditoleransi. Tujuan evaluasi resiko adalah untuk membantu dalam membuat keputusan, berdasarkan hasil analisis resiko, berkaitan dengan resiko yang memerlukan prioritas penanganannya.

Evaluasi resiko menggunakan perbandingan tingkat resiko yang ditemukan selama prosedur analisis dengan kriteria resiko yang dibuat ketika konteksnya ditetapkan. Evaluasi resiko juga dapat menyebabkan keputusan untuk tidak memperlakukan resiko dengan cara lain selain mempertahankan pengendalian yang ada.

4. Perlakuan resiko (Penanganan Resiko)

Penanganan resiko menggunakan pemilihan salah satu atau lebih untuk memilih memodifikasi resiko dan melaksanakan pilihan tersebut. Penanganan resiko terdiri dari atas :

- Menilai penanganan resiko
- Memutuskan apakah tingkat resiko residual yang ada
- Jika tidak ditoleransi, menghasilkan penanganan resiko yang baru
- Menilai efektivitas penanganan itu

5. *Monitoring* dan *review*

Merupakan tahap untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses dan fungsi manajemen resiko berjalan dengan baik. *Monitoring* adalah pemantauan rutin terhadap kinerja actual proses manajemen resiko dibandingkan dengan rencana yang dihasilkan.

Review adalah peninjauan atau pengkajian berkala atas kondisi saat ini dengan fokus tertentu. Pelaksanaan *monitoring* dan *review* secara berkelanjutan bertujuan untuk memberikan jaminan yang terhadap pencapaian sasaran penerapan sistem manajemen resiko secara keseluruhan.

3.4. Pencatatan dan Pelaporan

Pelaksanaan manajemen resiko di RS. Prima Husada dibuat dalam bentuk laporan berupa :

1. Profil resiko yang dilaksanakan setiap tahunan pada saat penyusunan rencana kerja.
2. Setiap masing-masing unit kerja membuat informasi mengenai resiko kunci yang di kelola, rencana mitigasi / pengelolaan, dan realisasi mitigasi / pengelolaan resiko yang dijalankan

BAB IV
PENUTUP

Panduan yang disusun ini merupakan langkah awal sebagai pedoman/panduan bagi rumah sakit untuk melakukan identifikasi evaluasi dan tindak lanjut terhadap risiko di rumah sakit. Panduan ini diharapkan dapat diterapkan oleh RS dan menjadi pedoman bersama dalam manajemen risiko.

Standar Akreditasi menekankan Manajemen Risiko dan Quality Improvement saling berkaitan. Standar Akreditasi menggambarkan adanya 2 sistem pokok dalam pengelolaan RS yaitu Sistem Pelayanan Klinis dan Sistem Manajemen didampingi Sistem Komunikasi & Informasi. Manajemen Risiko RS merupakan payung safety bagi sistem tersebut. Manajemen Risiko RS berakar pada Enterprise Risk Management

Dengan penerapan Manajemen Risiko RS maka RS, Pasien, Staf, Fasilitas, Lingkungan, Anggaran menjadi lebih aman. Implementasi di Rumah Sakit dimulai dengan menyusun dokumen “KEBIJAKAN dan STRATEGI TENTANG MANAJEMEN RISIKO”

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 November 2025
Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep. M.Kep.